

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 Intensivpflege-Halle-GmbH
Kennzeichen/ Fundstelle VA - III.5-20	Bezeichnung des Dokumentes: Feststellung des Kontrakturrisiko und Maßnahmen der Kontrakturenprophylaxe	

Durchführende:

- Pflegefachkräfte (PFK)/Pflegehilfskräfte (PHK)

Pflegeziel:

- Förderung des körperlichen und psychischen Wohlbefindens
- Erhaltung der funktionellen Bewegungsfähigkeit
- Verhinderung von Kontrakturen und Muskelatrophien (Muskelschwund)

möglicher Gefährdungen und Risiken die Bewegungseinschränkungen und Kontrakturen fördern:

- Arthritis, Arthrose, Rheumatismus, Gicht
- Bewegungsmangel/Immobilität, Schonhaltungen durch Schmerzen
- Nervenlähmungen
- degenerative Gelenkerkrankungen
- Bewusstlosigkeit, Langzeitbeatmung
- Zustand nach Frakturen, Gips-, Streck- oder Schienenverbände
- Schlaganfall mit Hemiplegie
- Erkrankungen des Weichteilapparates (Muskeln, Sehnen, Gelenke)
- Hirnerkrankungen/ -verletzungen
- selbstgewählte Ruhigstellung
- Depression, Demenz
- dermatogene Veränderungen (bspw. Narbenbildungen und andere Hautveränderungen mit Verkürzungstendenz (Verbrennungen)
- Morbus Parkinson
- Multiple Sklerose
- Sedative/Hypnotika
- Fixierungen inkl. fixierender Lagerung
- Gelenke in der Nachbarschaft einer Kontraktur

Indikation:

- Gelenkerkrankungen (Gicht, Arthrose, etc.) bzw.
- bei Erkrankungen des Weichteilapparates bzw.
- Nervenlähmungen (z. B. Hemiplegie) und zentrale Nervenschädigungen bzw.
- bei längerer therapeutischer Ruhigstellung bzw. bei Bewusstlosigkeit oder Lähmung bzw.
- nach ärztlicher Anordnung bzw.
- nach Abstimmung mit dem Physiotherapeuten/Ergotherapeuten

Kontraindikation:

- bei Ablehnung durch den Patienten

Vorbereitung:

- Patienten informieren
- Materialien für die Pflegemaßnahmen bereitlegen

Material:

- Lagerungsmaterialien, z.B. Kissen, Lagerungsschienen, Schalen, Polster

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2023		001	1	Verw./MA

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 Intensivpflege-Halle-GmbH
Kennzeichen/ Fundstelle VA - III.5-20	Bezeichnung des Dokumentes: Feststellung des Kontrakturrisiko und Maßnahmen der Kontrakturenprophylaxe	

Durchführung:

- die erste pflegefachliche Einschätzung (bei Aufnahme) zu Bewegungseinschränkungen bzw. vorhandenen Kontrakturen erfolgt durch die PFK in den Themenfeldern in der „Strukturierten InformationsSammlung“ (SIS) und es erfolgt eine Aufnahme in die Maßnahmenplanung
- treten Bewegungseinschränkungen oder Kontrakturen später neu hinzu, erfolgt eine Eintragung im Berichtblatt und die Anpassung der Maßnahmenplanung
- Ist eine Beratung erfolgt, wird dies inhaltlich kurz im zutreffenden Themenfeld beschrieben, später notwendig werdende Beratungen sind im Berichtblatt zu beschreiben
- grundsätzlich dient das Berichtblatt zur Erfassung veränderter pflegerischer Situationen als anlassbezogene Evaluation in akuten Situationen oder bei besonderen Ereignissen oder Veränderungen
- Zur Bewertung und Feststellung von Gefährdungen, Bewegungseinschränkungen bzw. vorliegenden Kontrakturen ist **durch die PFK** das/die betroffenen Gelenke zu beschreiben
- Die Maßnahmen der Kontrakturenprophylaxe sind grundsätzlich im Rahmen der aktivierenden Pflege vom Patienten soweit wie möglich selbst durchzuführen, Pflegekräfte motivieren und unterstützen
- Die festgelegten therapeutischen Maßnahmen sind umzusetzen, mit dem Physiotherapeuten ist sich abzustimmen, um so die geplanten physio-therapeutischen Maßnahmen weiter fortzusetzen.

Maßnahmen der Kontrakturenprophylaxe sind:

- Angehörige und Patienten sind über das Risiko einer Kontraktur und mögliche Hilfen im Rahmen der Kontrakturenprophylaxe zu beraten bzw. in Handlungen einzuweisen. Diese Beratung ist bei Bedarf, jedoch mindestens in halbjährlichen Abständen, zu wiederholen. Sind Patienten oder Angehörigen kognitiv nicht fähig den Inhalt zu verstehen und Hinweise umzusetzen bzw. sind Angehörige nicht erreichbar, so ist das Beratungsblatt einzulegen, im freien Textfeld sind die unternommenen Beratungsaktivitäten einzutragen. Die PFK/PHK handelt dann als Assistenz.
- Bewegungsübungen sind atraumatisch (schmerzfrei) auszuführen.
- durch wechselnde Lagerungen können die Bewegungsübungen ergänzt bzw. unterstützt werden. Die Lagerungen können in Rücken-, Seiten- oder Bauchlage unter Berücksichtigung der Neutral-Null Stellung erfolgen. Bei dieser Messmethode werden alle Gelenkbewegungen von einer einheitlich definierten 0-Stellung aus gemessen. Diese **Neutral-0-Stellung** entspricht der Gelenkstellung, die ein gesunder Mensch im aufrechten Stand mit hängenden Armen und nach vorn gehaltenen Daumen und parallelen Füßen einnehmen kann. (siehe Anlage)
- **passive Bewegungsübungen:**
halten und bewegen von kranken, gelähmten oder schwachen Gliedmaßen mindestens 3 x täglich mit jeweils 3 Wiederholungen durch langsames und vorsichtiges Beugen, Strecken und Drehen der Gelenke, jedes Gelenk (entsprechend den physiologischen Grundbewegungen), an den kleinen Gelenken beginnen und das nächstliegende Gelenk fixieren
- **aktive und aktiv-assistive Bewegungsübungen:**
durch den Betroffenen selbst oder unter Mithilfe einer Pflegeperson mehrmals täglich, Bewegung einzelner oder aller Gelenke, Sitzen im und außerhalb des Bettes, Lageveränderungen im Bett, Gehen mit Unterstützung einer Pflegekraft oder mit Gehhilfen, mindestens 3 x täglich mit jeweils 3 Wiederholungen
- Umsetzung der **Spitzfußprophylaxe** vor allem durch Nutzung von Bettverkürzern soweit möglich und Einzelfall angezeigt, bei kleinen Personen ist im Sitzen immer ein

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2023		001	2	Verw./MA

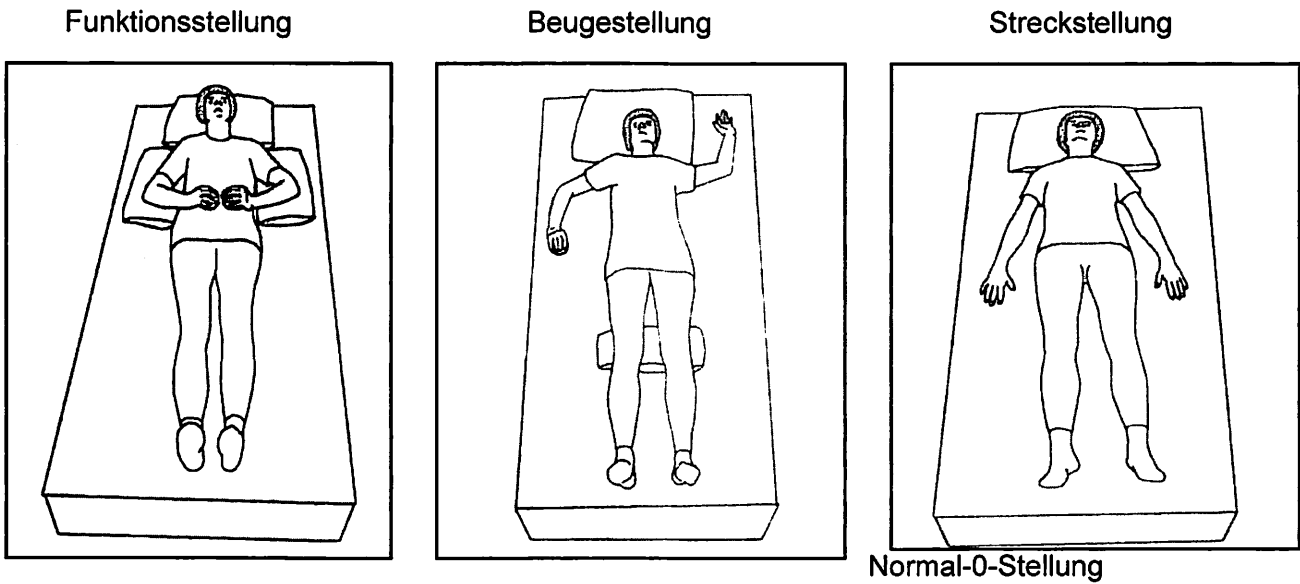
Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 Intensivpflege-Halle-GmbH
Kennzeichen/ Fundstelle VA - III.5-20	Bezeichnung des Dokumentes: Feststellung des Kontrakturnrisiko und Maßnahmen der Kontrakturenprophylaxe	

Fußwiderstabd herzustellen (Fußboden bzw. Fußstellklappen am Rollstuhl), der Bettdeckendruck ist keine Indikation für einen Spitzfuß

- **Hilfsmittel:**
sind zielgerichtet einzusetzen. Der Einsatz ist abzuwechseln um so eine einseitige Belastung der Gelenke zu vermeiden, Hilfsmittel müssen funktionsfähig sein.
- **Lagerungen:**
individueller Wechsel zwischen Beuge- und Streckstellung, dabei alle gefährdeten Gelenke entsprechend ihren physiologischen Möglichkeiten 3x bewegen. Sollte ein Lagewechsel nicht möglich sein, wird die Funktionsstellung angewendet, die Lagerungsintervalle werden mit dem Fingertest ermittelt.
- Anwendung des Bobath- Konzeptes vor allem bei Hemiplegikern (halbseitig gelähmte Menschen)

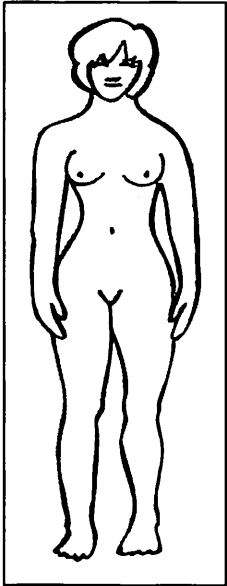
Nachbereitung:

- Dokumentation der Leistungsdurchführung
- Dokumentation aller Auffälligkeiten des körperlichen und seelischen Zustands oder Verweigerungen von Pflegemaßnahmen
- bei erheblichen Abweichungen und Auffälligkeiten Information an die PDL bzw. an die diensthabende PFK
- bei Notwendigkeit Anpassung der Maßnahmeplanung



Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2023		001	3	Verw./MA

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 Intensivpflege-Halle-GmbH
Kennzeichen/ Fundstelle VA - III.5-20	Bezeichnung des Dokumentes: Feststellung des Kontrakturrisiko und Maßnahmen der Kontrakturenprophylaxe	



Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2023		001	4	Verw./MA